

Modem: WD8738579D851
Unid: H369051642D06

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J36698333EE21

MAURO MARCAL RODRIGUES

IDADE: 73	PESO: 66	ALTURA: 170	PROFISSÃO: Mec. Aeron. / Professor
SINTOMAS: <i>ressequido</i>			
QUEIXAS: <i>Sonolência / Cefaleia muito de dia / Insônia</i>			
MEDICAMENTOS: <i>AAS Protecti / Trusol / Zelarox / Losartana / glifage / Homeprazol / Alopurinol / Dasteni</i>			
MÉDICO: <i>Dr. André Farinelli Lima - Dr. Genivaldo</i>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>musculação (2x)</i>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 00:00		HORA QUE ACORDA: 8hr	
COCHILHO (X) SIM () NÃO <i>varia vezes</i>		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO <i>(aravez)</i> <i>espora nemca</i>			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>mista</i>		BANHEIRO: 1 a 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>controlada</i> MALLAMPATI:		IAH: 48.8 e/ev SPO2: 92%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>Ponte de safena (2)</i>			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS			
02/09 Avaliação - <i>max. Wisp tecido</i>			
24			
09/09 P=9.6 <i>Boca aberta durante</i>			
24 IAH=2.6 <i>fixa</i>			
m. de uso: 3h42'			
09/12/24 <i>Não está usando; - Retorna o uso agora</i> <i>Auto 4210 cmH2O</i>			
18/12/24 P=6.3 cmH2O <i>pgs% = 9.5 cmH2O</i> <i>silva</i>			
IAH=3.8 e/ev			
m uso= 5h13 min <i>Fixo P: 8.0 cmH2O</i> <i>Silva</i>			
27/12/24 P=8.0 cmH2O <i>Bem adaptado</i>			
IAH=2.4 e/ev			
m uso= 6h13 min <i>↑ sempre 5 cmH2O</i> <i>Silva</i>			
fuga= 33 l/min			
03/01 P=8.0 cmH2O <i>* Oriento sobre a água</i>			
25 IAH=1.2 e/ev <i>do equip. p/ transporte</i>			
m de uso: 6h47' <i>trouxo com água</i>			
fuga= 0.2 l/min <i>fluo. claudia</i>			
10/02/25 P=8.0 cmH2O <i>Boca recu - sugiro minipore / língua céu</i>			
IAH=2.4 e/ev <i>boca</i>			
m uso= 7h30 min			
fuga= 1 min 50xkg			

17/03/25

P = 8,0 cm H₂O
IAH = 2,8 e/h
m. de uso: 7h22 min
fuga = 0

Bem adaptado

Silvêr

26/05/25

P = 8,0 cm H₂O
IAH = 3,0 e/h
m. de uso: 7h57'
Fuga = 0,0"

de 30d. usou 30d.

dua.

21/07/25

P = 8,0
IAH = 2,5 e/h
m. de uso: 5h30'
fuga = 0,0 lpu

mau cãndia

Nome: MAURO MARCAL RODRIGUES

Data de Nascimento: 14-11-1950

IMC: 26,85

Sexo: Masculino

Data do exame: 21-04-2024

Peso: 74 kg

Altura: 1,66 m

Médico: DR. ANDRÉ FARINELLI LIMA

BRITO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 21-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 571,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 278,0 minutos. O tempo total de sono foi de 375,0 min, eficiência de 65,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 71,6%; estágio N3: 7,5%; sono REM: 18,1%. O índice de despertares foi de 27,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 48,8/hora, sendo 7 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 244 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 72%, permanecendo 11,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 81 bpm e NREM de 51 - 78 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 48,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=72%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (24,0/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

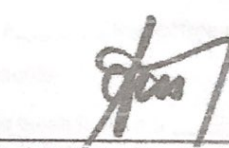
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57